Diskussion 1964

Datum: 1933-03-10
Kammare: Andra kammaren
Antal yttranden: 2
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Anders Hansson (Socialdemokraterna, man)

Herr förste vice talman! Jag kan icke låta denna fråga gå alldeles oanmärkt förbi, utan jag vill beledsaga den med några reflexioner, om det bör tillsättas manliga eller **kvinnliga¹** vårdare på våra sinnessjukhus. Jag ämnar icke göra något yrkande, men jag tror, att några ord i debatten ändå i alla fall kunna ha ett värde för framtiden.

Jag vill då säga, att beträffande kroppssjukvården är det så, att **kvinnliga¹** vårdare äro att föredraga framför manliga. Därom råda inga delade meningar. **Kvinnorna¹** äro lämpligare för detta, och de användas också över allt. Beträffande sinnessjukvården återigen måste man säga, att det icke i alla avseenden är riktigt lämpligt, att **kvinnliga¹** vårdare ersätta manliga. När det gäller sinnessjukvård av **kvinnliga¹** patienter, har man **kvinnliga¹** vårdare. Numare har man också, när det gäller samma vård av manliga patienter, som äro mycket lugna, **kvin nliga¹** vårdare. Jag har ingen anmärkning heller att göra mot att man för personer, som befinna sig på konvalescensens stadium, har **kvinnliga¹** vårdare. Man börjar emellertid att i oroväckande grad tillämpa principen att ha **kvinnliga¹** vårdare på halvoroliga och heloroliga avdelningar. Men man får icke gå för långt därvidlag. Jag vill icke uppehålla mig vid några detaljer, men jag kan tala om att det är verkligen upprörande scener, som ibland kunna utspelas på sinnessjukhusen, och de **kvinnliga¹** vårdarna kunna då icke med den respekt ej heller med den fysiska styrka som manliga vårdare sköta de sjuka.

Man har nu tillämpat ett slags delningssystem, så att man exempelvis har två eller tre manliga och en **kvinnlig¹** vårdare eller två manliga och två **kvinnliga¹**. Det visar sig då, att en **kvinnlig¹** vårdare har svårt att klara sig ensam på en avdelning. Oroliga patienter begå ibland våld på inventarier, slå sönder möbler o. dyl., och då måste man kunna avstyra detta. Det går icke om det icke finns människor, som äro så starka, att de kunna gripa verksamt in och det i rätta ögonblicket. Nu har man från läkarhåll tillämpat detta systemet manliga ellller **k vinnliga¹** vårdare olika. En del läkare ha gått längre och en del stannat vid att vara mera försiktiga. Jag skulle också här i debatten vilja framhålla, att man bör ha sin uppmärksamhet riktad på denna sak och för framtiden gå fram med större försiktighet. Jag ber att få säga, att, såsom ock torde framgå av mitt anförande, jag alls icke åsyftar något underkännande av den **kvinnliga¹** arbetskraftens värde. Jag ger tvärt om densamma det principiella erkännandet att den i allmänhet är lämplig. Det finns emellertid gränser, som man icke får överskrida. Det är också såsom en gärd av hänsyn till dessa **kvinnliga¹** befattningshavare, som jag säger detta, och därför är det också ett önskemål, att man i framtiden måtte taga all möjlig hänsyn till vad

jag sagt och tillse, att en väl avvägd balans i detta avseende iakttages. Jag tror icke, att man riktigt gjort detta i utskottet. Det hade då kanske funnits möjligheter att tillmötesgå den åsikt, jag här uttalat. I frågans nuvarande läge har jag emellertid intet yrkande.

till Västernorrlands läns landsting ej mindre — utöver det byggnadsbidrag, som jämlikt gällande bestämmelser beträffande statsbidrag till uppförande eller inrättande av tuberkulossjukvårdsanstalter tillerkänts eller kunde komma att tillerkännas landstinget för uppförandet av en vid länssanatoriet i Sundsvall anordnad barnpaviljong med 72 vårdplatser — ett extra byggnadsbidrag av 1,000 kronor för varje vårdplats, än även — utan hinder av nyssnämnda bestämmelser — statsbidrag till anordnande av 40 nya vårdplatser vid den nuvarande tuberkulossjukvårdsavdelningen vid länslasarettet i Örnsköldsvik i samband med en planerad omändring av nämnda avdelning till ett självständigt sanatorium med ett belopp av 3,000 kronor för varje vårdplats, isoleringsplatser ej inräknade;

till Västernorrlands läns landsting — utan hinder av gällande bestämmelser 1 ämnet — statsbidrag till anordnande av 40 nya vårdplatser vid den nuva-

2. Gerhard Strindlund (Bondeförbundet, man)

Herr talman! Såsom byggnadsbidrag till tuberkulosanstalterna utgå, såsom vi veta, av statsmedel 2,000 kronor per vårdplats, men på grund av tuberkulosens våldsamma utbredning och dessutom de svåra ekonomiska förhållandena i de norrländska länen ha till dem brukat utgå förhöjda byggnadsbidrag. Man kan säga, att till Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län i runt tal utgått i statsbidrag till byggnadskostnader 5,000 kronor per vårdplats, alltså ett med 3,000 kronor förhöjt byggnadsbidrag. Även från Västernorrlands län gjordes i november 1931 en framställning om ett förhöjt byggnadsbidrag i överensstämmelse med vad som brukat utgå till de övriga norrländska länen. Ur motiveringen för landstingets framställning skulle Jag vilja återge en del uttalanden. Man har bland annat här påtalat de våldsamma kostnader, som speciellt landstinget haft för ordnandet av tuberkulossjukvården. I denna skrivelse uppges den sammanlagda kostnaden till 3,194,000 kronor och genom denna uppoffring äger detta län ett större antal vårdplatser per tusen invånare än vad som gäller för riket i dess helhet. "Trots de ansträngningar, som landstinget gjort för att bereda tillfälle till vård av lungtuberkulösa, finna vi emellertid, att väntetiden vid de olika sanatorierna är synnerligen lång. Vid den tidpunkt, då denna skrivelse avlämnades, uppgavs den vara vid Örnsköldsviks sanatorium icke mindre än 141 dagar för män och 190 dagar för **kvinnor**[1], och vid Sundsvalls sanatorium uppgavs den vara 119 dagar för män och 103 dagar för **kvinnor**[1]. Jag ber också att få påpeka, att vad som bland annat stämde riksdagen mildare, då det gällde utmätandet av anslagen

Jag ber att få påpeka, att den framställning, som gjordes av landstinget, också är tillstyrkt av flera myndigheter. Man bör i detta fall erinra om vad från länsstyrelsen framhålles, vilket återfinnes på sidan 155 i femte huvudtiteln, och ur detta ber jag att få citera: »Olikheterna beträffande den ekonomiska ställningen och tuberkulosens utbredning mellan Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, å ena, samt Västernorrlands län, å andra sidan, syntes ej

vara av sådan omfattning, att de motiverade en mindre förmånlig ställning för Västernorrlands län än för övriga angivna län. Till stöd för denna sin uppfattning finge länsstyrelsen till jämförelse med den av länets landsting år 1931 beslutade utdebiteringen framhålla, att utdebiteringen samma år bestämts till i Norrbottens län 3 kronor 30 öre, i Västerbottens län lägst 3 kronor 19 öre och högst 3 kronor 25 öre samt i Jämtlands län 3 kronor 10 öre.» Jag ber att få påpeka, att vi inom Västernorrlands län nödgats utdebitera en landstingsskatt, som uppgår till icke mindre än 3 kronor 40 öre per skattekrona. Sålunda kunna vi, då det nu gäller frågan om ett förhöjt byggnadsbidrag till Västernorrlands läns landsting, konstatera, att vi för närvarande ha en högre utdebitering än vad man hade i Norrbottens län, då detta län erhöll förhöjt statsbidrag. Vårt län har tyvärr nu blivit det fjärde i ordningen i fråga om att ha en hög landstingsskatt. Jag ber också få framhålla, att det län, som det här är fråga om att ge ett handtag, kanske svårast lider av de nuvarande tryckta förhållandena. Vi veta, att det säkerligen icke är något län, som i förhållande till sin förmåga får göra sådana uppoffringar för bland annat arbetslöshetens bekämpande som Västernorrlands län.

Jag kan icke undgå att även påpeka, att det sätt, varpå utskottet motiverat sitt ställningstagande, då utskottet går mot Kungl. Maj:ts förslag i vissa delar av den föreliggande frågan, är rätt märkligt. Saken omnämndes redan i fjolårets statsverksproposition, men på grund därav att frågan ansågs behöva underkastas ytterligare utredning, gjordes icke något äskande av den dåvarande socialministern. Denna anmälan lämnades utan erinran från riksdagens sida.

Vad rör det sig då om för belopp? Jag har redan nämnt, att Västernorrlands läns lansting begärt att få samma tillägg i byggnadsbidrag, som beviljats de tre andra länen, men det är därför icke sagt, att Västernorrlands län skulle få samma ställning som de andra norrländska länen, därför att till dessa har dessutom utgått ett förhöjt driftkostnadsbidrag under viss tid i samband med ombyggnaden. Västernorrlands läns landsting har begärt att få ett förhöjt byggnadsbidrag av 3,000 kronor per vårdplats för sammanlagt 112 platser. Skulle denna framställning bifallas, skulle anslaget sålunda uppgå till ett belopp av 336,000 kronor. Kungl. Maj:t har icke tillmötesgått denna framställning utan tillstyrkt ett förhöjt byggnadsbidrag med 1,000 kronor per vårdplats, vilket enligt samma proportion skulle utgöra 112,000 kronor. Utskottet å sin sida tar bort vad Kungl. Maj:t föreslagit till de 72 platserna vid Sundsvalls sanatorium och tillstyrker blott 40,000 kronor, sålunda ungefär endast ?/,, av vad Västernorrlands län, om man här gör jämförelse med vad de övriga länen fått, borde kunna vara berättigat till.

Jag kan för min del icke finna, att det föreligger några som helst skäl för riksdagen att ställa sig så avog, som utskottet här gjort. Följer man Kungl.

Ang. bidrag till tuberkulossjukvårdsanstalter. (Forts.) Maj:t, har man i alla fall för Västernorrlands läns vidkommande icke gått med på mer än 1,000 kronors tillägg per

vårdplats, under det att man ansett skäligt att tilldela de andra länen tre gånger så höga tilläggsanslag. Som man härav finner, är vad Kungl. Maj:t föreslagit ett mycket rimligt krav, och jag ber i anledning härav att få yrka bifall till reservationen, som överensstämmer med vad Kungl. Maj:t föreslagit.